



🌱 Teoria das Necessidades Básicas (Wanda Horta)

- **Psicobiológicas:** oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono, repouso, locomoção, cuidado corporal, integridade cutânea
- **Psicossociais:** comunicação, interação social, lazer, segurança emocional, autoestima
- **Psicoespirituais:** crenças, valores, religiosidade, transcendência

💡 **Pensamento-chave:** O cuidado de enfermagem visa atender necessidades afetadas em cada nível, de forma integral.

🔄 SAE — 5 Etapas

1. **Histórico de Enfermagem:** Coleta de dados (entrevista + exame físico)
2. **Diagnóstico de Enfermagem:** Julgamento clínico (taxonomia NANDA-I)
3. **Planejamento:** Definição de resultados (NOC) e intervenções (NIC)
4. **Implementação:** Execução das intervenções planejadas
5. **Avaliação:** Verificação dos resultados alcançados

⚖️ **Base legal:** Resolução COFEN 358/2009 — SAE é privativa do enfermeiro.

💊 Administração de Medicamentos — 7 Certos

- ① **Paciente certo** — confira nome + identificação
- ② **Medicamento certo** — compare com a prescrição
- ③ **Dose certa** — calcule e confira
- ④ **Via certa** — enteral (VO, SL, sonda) × parenteral (ID, SC, IM, EV)
- ⑤ **Horário certo** — respeite o intervalo prescrito
- ⑥ **Registro certo** — anote imediatamente após administrar
- ⑦ **Orientação certa** — informe o paciente sobre a medicação

💉 Vias Parenterais — Comparativo

Via	Ângulo	Vol. máx.	Exemplo
ID (intradérmica)	10–15°	0,5 mL	PPD, BCG
SC (subcutânea)	45–90°	1–2 mL	Insulina, heparina
IM (intramuscular)	90°	3–5 mL	Benzetacil, dipirona
EV (endovenosa)	25–45°	Variável	Soro, antibióticos

Locais IM: deltoide (2 mL), vasto lateral (5 mL), glúteo (4 mL).

🧼 Assepsia, Antissepsia e Higiene do Paciente

🧴 Conceitos:

- **Assepsia:** Ausência de microrganismos (campo estéril)
- **Antissepsia:** Redução de microrganismos na pele (álcool 70%, PVPI, clorexidina)
- **Degermação:** Lavagem das mãos com água e sabão

👐 5 Momentos da Higienização (OMS):

1. Antes de tocar o paciente
2. Antes de procedimento limpo/asséptico
3. Após risco de exposição a fluidos
4. Após tocar o paciente
5. Após tocar superfícies próximas

🏠 Cuidados de higiene:

- Banho no leito (passos: material → segurança → privacidade → técnica)
- Mudança de decúbito (a cada 2h — prevenir lesão por pressão)
- Cama hospitalar: ocupada × desocupada, posições (Fowler, Sims, Trendelenburg)

Curativos e Feridas

Classificação de feridas:

- **Quanto à causa:** cirúrgica, traumática, ulcerativa
- **Quanto à contaminação:** limpa, limpa-contaminada, contaminada, infectada
- **Quanto ao tempo:** aguda (até 6 semanas) × crônica (> 6 sem)

Coberturas comuns:

- **Hidrocoloide:** feridas secas a pouco exsudativas
- **Alginato:** feridas muito exsudativas
- **Carvão ativado:** feridas infectadas com odor
- **Espuma (poliuretano):** feridas moderadamente exsudativas
- **Filme transparente:** proteção de pele íntegra, cobertura de cateteres

Oxigenoterapia & Cateterismos

Oxigenoterapia:

- **Cateter nasal:** 1–5 L/min (FiO₂ 24–40%)
- **Máscara simples:** 5–10 L/min (FiO₂ 35–50%)
- **Máscara Venturi:** fluxo exato, FiO₂ controlada (24–50%)
- **Máscara c/ reservatório:** 10–15 L/min (FiO₂ 60–95%)

Cateterismos:

- **SNG:** descompressão gástrica, lavagem, coleta
- **SNE:** administração de dieta/medicação
- **Sonda vesical (de alívio/demora):** esvaziamento vesical, controle de diurese
- **Sonda retal:** eliminação de gases, fecaloma

Admissão, Alta, Processo Pós-Morte, Contenção

Admissão:

- Identificação + pulseira
- Sinais vitais
- Histórico e exame físico
- Vaga, leito, pertences

Transferência/Alta:

- Resumo de alta (evolução)
- Orientações ao paciente
- Receitas e atestados
- Desocupação do leito

Pós-morte:

- Declaração de óbito (médico)
- Preparo do corpo: higiene, identificação, posição (decúbito dorsal)
- Aspectos legais e éticos
- Respeito à família e crenças

Contenção:

- **Mecânica:** faixas (punho, tórax, joelhos)
- **Química:** sedação medicamentosa
- **Ambiental:** grades, cama baixa
- Cuidados: avaliar q 1h, liberar q 2h

Terminologias Técnicas Essenciais

Termo	Significado
Afebril	Sem febre
Normocárdico	FC normal (60-100 bpm)
Eupneico	Respiração normal (16-20 irpm)
Normotenso	PA normal (120/80 mmHg)
Anictérico	Sem icterícia
Normocorado	Coloração normal da pele/mucosas
Hidratado/Desidratado	Turgor e elasticidade da pele
Lúcido e Orientado	Consciente, responde a comandos
Diurese presente/ausente	Volume urinário normal/alterado
Eliminações fisiológicas	Urina e fezes dentro da normalidade

Exames, Coletas, Crioterapia & Termoterapia

Coletas comuns:

- **Sangue:** punção venosa — torniquete, assepsia, agulha, frasco
- **Urina:** jato médio, 24h, urocultura (jato médio)
- **Fezes:** parasitológico, sangue oculto
- **Escarro:** matinal, jejum, lavagem brônquica

Medidas antropométricas:

- Peso, altura, IMC (kg/m²), circunferência abdominal
- Classificação IMC: <18,5 magreza | 18,5-24,9 normal | 25-29,9 sobrepeso | ≥30 obesidade

Crioterapia ❄️: bolsa de gelo 20min — edema agudo, dor, processo inflamatório

Termoterapia 🔥: bolsa de água quente 20min — contraturas, abscesso, dor crônica

Cama Hospitalar e Posições

Cama ocupada × desocupada:

- **Desocupada:** leito vazio, roupa limpa completa
- **Ocupada:** paciente no leito, troca parcial (lençol móvel, fronha)

Posições principais:

- **Fowler (45°):** dispneia, alimentação
- **Semi-Fowler (30°):** conforto, repouso
- **Sims (decúbito lateral):** SNE, procedimentos retais
- **Trendelenburg:** choque, hipotensão
- **Decúbito dorsal:** exame físico, repouso

★ Dicas de Memorização

Mnemônicos úteis:

- **SAE:** HDPIA — "Hoje Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Avaliação"
- **7 Certos:** P M D V H R O — "Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Orientação"
- **Vias parenterais (ângulo):** ID 15°, SC 45°, IM 90° — "15, 45, 90: quanto + fundo, maior o ângulo"
- **5 momentos da higienização:** "Antes do paciente, Antes do procedimento, Após fluido, Após paciente, Após ambiente"